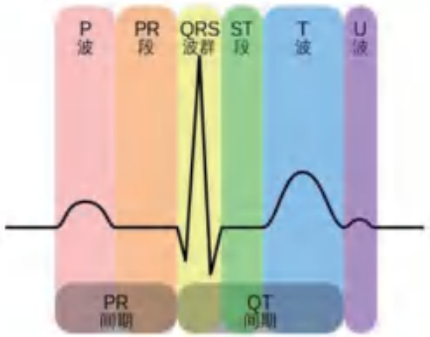


内科含诊断心律失常 ★★★（1~3 题）

- 严重缓慢型：起搏器（2023、2024）
  - VDD：窦房结功能正常 + 严重房室阻滞
  - DDD：病窦 + 严重房室阻滞
  - AAI：病窦 + 房室传导正常
  - （慢性房颤不用 AAI、DDD）
- 血压正常我用药
  - yyds
    - β-R 拮抗剂（Ⅱ）—— 房扑房颤（控心率首选）、阵发性室上速等
    - 胺碘酮（Ⅲ，2007、2014、2018）—— 房扑房颤、阵发性室上速
急性心梗所致室早室速等
  - 室早 —— 器质性心脏病、低钾血症、强心苷中毒等（2018、2025）
  - 阵发性室上速（2025）
    - 心电生理检查最佳：慢快型房室结折返（多由房早触发）
    - 突发突止、心率一般 160~250 次 / 分、心律绝对规则
    - 刺激迷走神经（按摩一侧颈动脉窦、Valsalva 等）
无效首选腺苷，次选维拉帕米、地尔硫卓等，有收缩性心衰用强心苷
    - 预激综合征伴室上速禁用强心苷
  - 房颤“怕栓怕快”（2010、2026）
    - 病因：二狭、甲亢等（2011、2020）
    - 体征（2010、2012、2019、2020）—— 心律绝对不齐、S1 强弱不等、脉搏短绌（P ＜心率）
听不到 S4、二狭心尖舒张晚期杂音可消失
    - 根治：导管消融（2023）
    - 长期抗凝（2017、2018）
      - 有瓣膜病→华法林（维持 INR 在 2~3）“林 I23”
      - 无瓣膜病
        - CHA2DS2-VASc：男 0 分或女 1 分不抗凝
（心衰、高血压、≥ 75 岁、糖尿病、脑卒中 / 栓塞 /TIA、血管疾病、65~74 岁、女）
        - 达比加群、利伐沙班，左心耳封堵（HAS-BLED ≥ 3 分）
    - 控心率（2009）—— β-R 拮抗剂（首选）、非二氢吡啶 CCB、强心苷等
强心苷用药史 + 心律规则 + 心室率慢→三度房室阻滞
    - 转复并维持窦性心律（2013）
      - 导管消融、胺碘酮、普罗帕酮、伊布利特等
      - 若房颤持续＞ 48 小时：抗凝 3 周 / 肝素紧急 /TEE- 转复 - 抗凝 4 周
（直接转复可致脑栓塞、肠系膜上动脉栓塞等）
    - 预激综合征伴房颤 —— ①首选电复律，或伊布利特、普罗帕酮“普通的伊布”
②禁用强心苷、维拉帕米、地尔硫卓、β-R 拮抗剂、胺碘酮